

ウェルニッケ脳症 画像と臨床をつなぐ確認カード

1. 背景と症状を結びつける

摂取不良・嘔吐・消化管手術などの背景と、意識変容・眼球運動異常・失調を確認。飲酒歴がないことや三徴の欠如だけで除外しない。

2. Caine基準の4項目

食事性欠乏／眼球運動異常／小脳機能障害／意識変容または軽度記憶障害。**4項目中2項目**。アルコール症例で作成・検証された基準で、非アルコール性への使用は援用。ほかの原因の検討も必要。

3. MRIの確認部位

内側視床・乳頭体・視蓋板・中脳水道周囲。左右対称のT2/FLAIR信号変化などを確認。全ての部位が揃う必要はなく、**MRI陰性でも除外しない**。画像だけで診断を完結させない。

4. 対応を遅らせない

疑ったWEには速やかなチアミン対応。検査結果やMRIの確定を待たない。**低血糖へのブドウ糖投与をチアミン待ちで遅らせない**。量・回数・期間は第4回で別途整理。

出典:Caine et al. JNNP 1997 (PMID 9010400)／EFNS 2010 (20642790)／Zuccoli 2009 (19155417)／Schabelman & Kuo 2012 (22104258)。文献詳細と実MRIは同梱ブログ参照。2026-09-09確認。一般的教育情報であり個別の治療指示ではありません。